

Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo · Documento DT-07
Borrador para comentarios. No citar sin contrastar.

Comparado con qué

Los indicadores de acceso del sistema colombiano frente a los referentes internacionales, y el estándar que la ley ordenó fijar hace diez años

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Ex asesor de Innovación y Analítica, ADRES.

Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE).
Septiembre de 2026

Versión 1.0 · 12 de septiembre de 2026 · Cítese la versión. Las correcciones posteriores a la publicación quedan con fecha en la fe de erratas: datos.sinergistica.com/erratas.html

Resumen

Los seis documentos anteriores de esta serie establecen niveles. Este responde la pregunta que sigue: si esos niveles son buenos, malos o aceptables, y contra qué referente. La respuesta tiene tres partes.

Primera: no existe ningún estándar internacional de derechos humanos que fije un umbral numérico de cumplimiento, y la omisión es deliberada. La Observación General 14 del Comité DESC establece que la aplicación precisa de los elementos esenciales «dependerá de las condiciones prevalecientes en cada Estado parte» e invita a los Estados a fijar sus propias referencias. El marco de derechos aporta el método, no la cifra. Lo que sí es no derogable es la obligación básica de facilitar medicamentos esenciales, y el criterio de violación no es porcentual sino de esfuerzo: distinguir la incapacidad de la falta de voluntad, con la carga de la prueba en el Estado.

Segunda: de los cuatro indicadores examinados, solo uno tiene referente internacional plenamente comparable —la afiliación—, y es el único donde a Colombia le va bien. El ODS 3.b.3 mide establecimientos y no personas; la encuesta del Commonwealth Fund mide renuncia por costo y no falla de entrega; la OCDE no publica tiempos de espera en urgencias; y la serie europea de necesidad no satisfecha usa una ventana de doce meses frente a los treinta días colombianos y restringe las razones admitidas. Reponderado a esas razones, el indicador colombiano queda en el rango europeo, de modo que la brecha aparente es sobre todo un artefacto del instrumento.

Tercera: Colombia tiene desde 2015 el mandato legal de fijar su propia vara. Los informes de goce efectivo existen para 2021 a 2024, ninguna resolución adopta la batería de indicadores, ninguno de los tres indicadores de medicamentos declara meta, y en septiembre de 2025 la Corte Constitucional calificó el cumplimiento como bajo y la falta de continuidad metodológica como un «retroceso sustantivo». El documento cierra comparando las dos cifras oficiales que hoy coexisten sobre el mismo fenómeno —27,93 % y 46,9 %— y sostiene que esa coexistencia no conciliada, sin meta en ninguna de las dos, es en sí misma el problema.

Palabras clave

gocce efectivo del derecho a la salud; Observación General 14; AAAQ; ODS 3.b.3; ODS 3.8.1; comparabilidad internacional; indicadores de derechos humanos; ENCV; SGSSS

1. La pregunta

Los seis documentos anteriores de esta serie establecen niveles. En 2025, el 46,9% de las personas con fórmula médica no recibió todo lo formulado; el 35,9% de quienes tuvieron un problema de

salud no recibió atención; el 36,0% de quienes acudieron a urgencias esperó más de una hora; el 97,2% de la población está afiliada.

La pregunta que sigue es la que decide si esas cifras sirven para algo: **¿son buenas, malas o aceptables?** ¿Aseguran el goce efectivo del derecho? ¿Existe un referente —los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un marco de derechos humanos, un promedio de la OCDE— contra el cual medirlas?

Este documento responde esa pregunta, y la respuesta tiene tres partes. La primera es que **no existe ningún estándar internacional de derechos humanos que fije un umbral numérico** de cumplimiento para ninguno de estos indicadores, y que esa ausencia es deliberada. La segunda es que los referentes cuantitativos que sí existen miden, en casi todos los casos, algo distinto de lo que mide una encuesta de hogares — y confundirlos produciría comparaciones falsas. La tercera es la más incómoda: **Colombia tiene desde 2015 el mandato legal de fijar su propia vara y no lo ha hecho**, y la Corte Constitucional lo declaró expresamente en septiembre de 2025.

El hallazgo transversal. *Los tres indicadores donde a Colombia le va mal son precisamente aquellos para los que no existe un referente internacional que permita decir «bueno» o «malo». El único donde le va bien —la afiliación— es el que sí tiene referente consolidado. La ausencia de vara no es neutral: impide tanto absolver como condenar, y hoy opera de hecho como una absolución.*

2. Qué clase de estándar puede existir

2.1 El marco de derechos no da cifras, y lo dice

El artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 enumera los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud —disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad—. No es una construcción colombiana: reproduce el esquema que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU fijó en su Observación General 14 del año 2000, conocido por sus iniciales en inglés como marco **AAAQ**.

Quien busque en ese documento un umbral no lo va a encontrar, y el texto explica por qué. El párrafo 12 dice que los cuatro elementos son «elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación precisa *dependerá de las condiciones prevalecientes en cada Estado parte*». El párrafo 57 dice que las estrategias nacionales de salud «deberían identificar indicadores y referencias apropiados del derecho a la salud», sin definirlos. Y el párrafo 58 es explícito: se invita a los Estados «a fijar referencias nacionales apropiadas en relación con cada indicador».

El umbral lo pone el Estado. El marco de derechos humanos aporta el método, no la cifra.

Eso no significa que no haya piso. El párrafo 43 establece **obligaciones básicas** que ningún Estado puede incumplir, y el literal (d) es «facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS». Esas obligaciones son *no derogables*. Y el párrafo 47 fija el criterio para evaluar una violación, que no es porcentual sino de esfuerzo: hay que distinguir la *incapacidad* de la *falta de voluntad*, y un Estado que «no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que dispone» está en violación del artículo 12. La carga de la prueba recae sobre el Estado.

La guía de indicadores de derechos humanos del ACNUDH (2012) confirma la misma lógica desde el lado técnico. Distingue indicadores estructurales, de proceso y de resultado, e incluye explícitamente entre los atributos del derecho a la salud la «accesibilidad a establecimientos de salud y medicamentos esenciales». Sobre las referencias dice que son «valores predeterminados para los indicadores que pueden basarse en consideraciones *normativas o empíricas*», y su propio ejemplo es condicional: para inmunización, una referencia «puede requerir fijar un valor específico, *digamos*, elevarlo al 90 %, o mejorar la cobertura existente en 10 puntos porcentuales». El número queda del lado del Estado.

2.2 Lo que se sigue de ahí

Una consecuencia práctica que conviene enunciar antes de seguir: **ninguna afirmación de la forma «el 46,9 % viola el derecho a la salud» tiene respaldo en el marco internacional**, y quien la haga estará usando el lenguaje de los derechos para una conclusión que ese lenguaje no autoriza. Lo que sí autoriza es una pregunta distinta y más difícil de responder con evasivas: dado ese nivel, ¿el Estado está usando el máximo de los recursos de que dispone?

3. Los referentes que sí existen, y qué miden realmente

3.1 El ODS 3.b.3 mide anaqueles, no personas

El indicador 3.b.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es «proporción de establecimientos de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles con carácter sostenible». Su unidad de observación es el **establecimiento** —farmacia, hospital, centro de atención primaria—, no la persona.

Su metadato oficial fija dos umbrales. El primero es de disponibilidad: un establecimiento «cuenta» si *al menos el 80 % de los medicamentos encuestados están simultáneamente disponibles y son asequibles*. El segundo es de asequibilidad, definido por el número de jornadas de salario adicionales que el trabajador público no calificado peor pagado necesitaría para costear el tratamiento: es asequible si ese número es menor o igual a uno.

Conviene evitar aquí una confusión frecuente. Ese 80 % del ODS **no es una meta**: es un umbral de clasificación que convierte una variable continua en binaria. La meta del 80 %, que sí existe, viene de otro lado —de la meta voluntaria número 9 del Plan de Acción Mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, avalada por la Asamblea Mundial de la Salud con horizonte 2025—. Son dos cosas distintas que comparten la cifra.

Y el balance de esa meta es contundente. Un análisis secundario de 71 encuestas en 54 países de ingreso bajo y medio, publicado en *The Lancet Global Health* en enero de 2025, encontró que **ninguna región de la OMS alcanza el 80 %**, ni en el sector público ni en el privado.

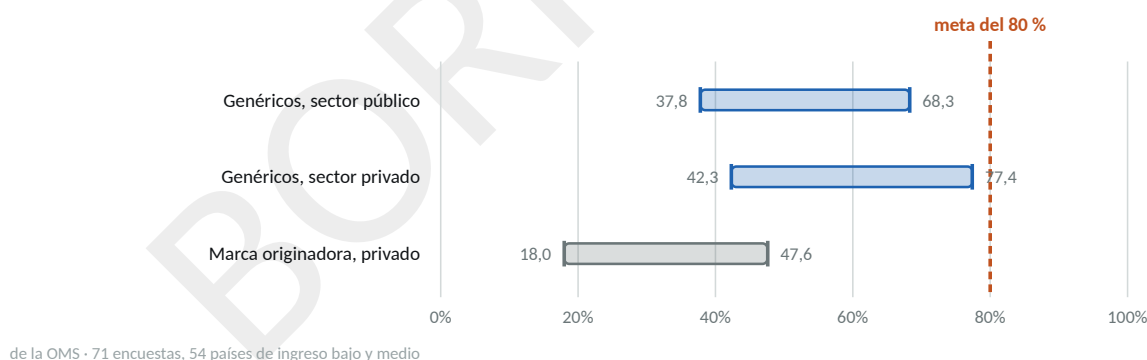


Figura 1. Disponibilidad de medicamentos esenciales en establecimientos, rango entre las seis regiones de la OMS. La línea punteada es la meta del 80 % del Plan de Acción Mundial sobre enfermedades no transmisibles. Obsérvese que la unidad es el establecimiento: mide si el medicamento está en el anaquel el día de la encuesta, no si el paciente salió con él. Fuente: Oldfield, Penm, Mirzaei y Moles (2025), sobre 71 encuestas en 54 países.

De ahí se sigue el límite: **disponibilidad en anaquel no es entrega efectiva**. Un país puede tener 70 % de disponibilidad y una proporción alta de pacientes que salen sin su medicamento, o al revés. El ODS 3.b.3 y el indicador de este trabajo son complementarios, no comparables. Y hay algo que decir a favor del segundo: mide el desenlace para la persona, que es lo que el derecho protege.

3.2 El indicador que sí compara a Colombia, y no mide afiliación

El ODS 3.8.1 es el índice de cobertura de servicios de salud esenciales: un compuesto de catorce indicadores trazadores, en escala de 0 a 100. Colombia obtiene **82** en 2023, frente a 79 de América Latina y el Caribe y 71 del promedio mundial.

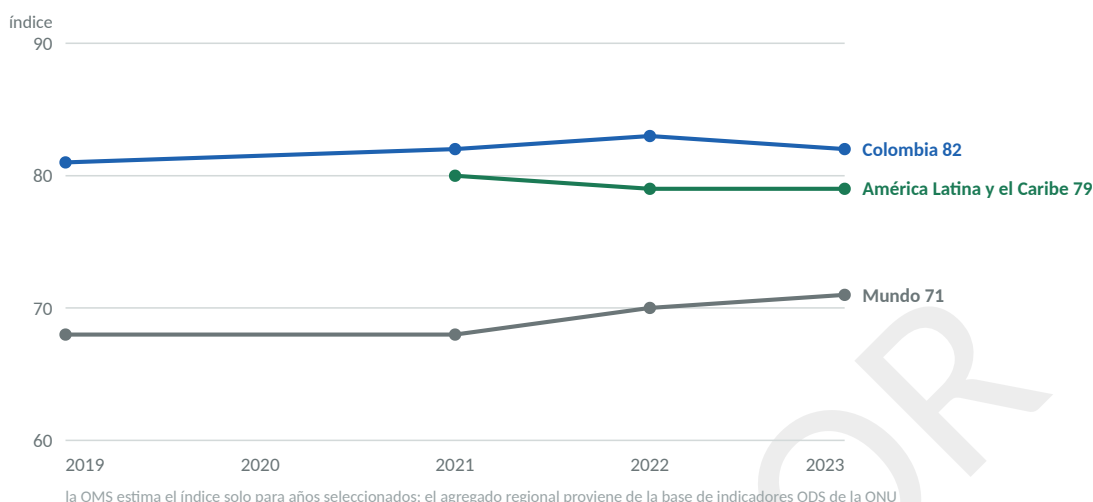


Figura 2. Índice de cobertura de servicios de salud, ODS 3.8.1, 2019–2023. Colombia está por encima del promedio regional y once puntos sobre el mundial. El índice mide cobertura *efectiva de servicios*, no afiliación. Fuentes: Observatorio Mundial de la Salud de la OMS para Colombia y el agregado mundial; base de indicadores ODS de las Naciones Unidas para el agregado de América Latina y el Caribe. La OMS estima el índice solo para años seleccionados.

Ese contraste es, a mi juicio, el más útil de todo este documento. **Colombia tiene 97,2 % de afiliación y 82 sobre 100 de cobertura efectiva de servicios.** Los tres indicadores adversos de esta serie — medicamentos, acceso y oportunidad— son precisamente la medición de la distancia entre esas dos cifras. El aseguramiento colombiano es un logro real y verificable; no es evidencia de acceso.

Sobre la afiliación misma hay dos referentes y conviene no mezclarlos. La OCDE reporta para Colombia una cobertura poblacional de **98,9 %** en 2023 —su propia nota de país la redondea a 99 %—, por encima de Estados Unidos (92,4 %), México (77,6 %), Costa Rica (93,0 %), Estonia (94,8 %) y Polonia (96,9 %), pero por debajo de los veintinueve países que están en 100 %. Esa cifra viene de registro administrativo. La de la ENCV —97,2 %— viene de autorreporte en hogares. Para un ranking OCDE corresponde la primera; la segunda sirve para la serie histórica y las desagregaciones.

3.3 Medicamentos: el referente que no existe

Para el indicador central de esta serie no hay estándar internacional medido en hogares. Hay dos cosas que se le parecen y no lo son.

La encuesta internacional del Commonwealth Fund pregunta si la persona «dejó de surtir una receta, o saltó dosis de su medicamento, *por el costo*». En su ronda de 2024, con adultos mayores de diez países, la renuncia por costo va de cerca del 1 % en el Reino Unido a alrededor del 12 % en Estados Unidos —órdenes de magnitud, no cifras verificadas dígito a dígito contra el cuadro publicado—. Es un buen indicador y no es el nuestro: atribuye la causa al bolsillo del paciente. Un sistema con 97 % de afiliación y dispensación sin cobro puede tener 0 % en ese ítem y una falla de entrega elevada. No debe usarse el 12 % estadounidense como vara del 46,9 % colombiano.

La Pesquisa Nacional de Saúde de Brasil, en cambio, sí mide lo mismo. En 2019 encontró que el 81,8 % de los usuarios del SUS con receta obtuvo *todos* los medicamentos recetados por cualquier vía, frente a 78,4 % en 2013: cerca del 18 % no obtuvo todo. Es el único comparador defendible que encontré, y aun así con dos salvedades que no son menores. La ventana brasileña es de dos semanas, no de treinta días. Y el denominador se restringe a los usuarios del SUS, es decir, deja fuera a la población con plan privado: entre quienes obtuvieron sus medicamentos exclusivamente por la red

pública del SUS la cifra de acceso total es del 70,3 %, o sea un 29,7 % de entrega incompleta, mucho más cercano al dato colombiano. Cuál de las dos cifras brasileñas es el comparador correcto depende de qué se considere análogo al SGSSS, y no hay una respuesta obvia: por eso el rango 18–30 % es más honesto que cualquiera de sus extremos.

3.4 Acceso: comparable en estructura, no en nivel

La necesidad de atención no satisfecha sí tiene un referente internacional consolidado: la serie de EU-SILC, la encuesta armonizada de ingresos y condiciones de vida de la Unión Europea. En su versión con denominador análogo al colombiano —personas que declararon esa misma necesidad— el promedio de la UE-27 es de **3,6 %** en 2024 y en 2025, con Grecia en 21,9 % y Chipre en 0,1 %.

Colombia registra 35,9 %. Poner las dos cifras en una misma tabla sería un error, y por cuatro razones simultáneas: la ventana europea es de doce meses y la colombiana de treinta días; la europea restringe las razones a costo, lista de espera y distancia, mientras la colombiana admite cualquiera; la europea se limita a mayores de dieciséis años; y hay diferencias de formulación del ítem.

Ahora bien, esas cuatro diferencias no hay que enunciarlas: hay que hacerles la aritmética, y hacerla invierte la conclusión intuitiva. Es cierto que una ventana de treinta días produce mecánicamente prevalencias más bajas que una de doce meses, y ese sesgo juega en contra de Colombia. Pero es el sesgo pequeño. El grande es la restricción de razones, y juega en sentido contrario.

Si del indicador colombiano se conservan únicamente las razones que EU-SILC admite —falta de dinero, y distancia o dificultad para viajar—, el 35,9 % baja a **3,51 %** (IC 95 %: 2,63–4,39), frente al 3,6 % de la UE-27: cifras indistinguibles. Si además se añaden, como cota superior generosa, todas las razones de oferta —mal servicio, cita distanciada, lo hacen esperar mucho, no lo atendieron— para sustituir la «lista de espera» europea, el resultado sube a **7,76 %** (6,27–9,25), alrededor del doble del promedio europeo y aún un orden de magnitud por debajo de la cifra bruta.

Tres consecuencias, y la segunda corrige a este mismo autor. La comparación cruda no era una comparación: casi toda la brecha aparente la produce la lista de razones. La lectura contraria —que la ventana corta hunde la cifra colombiana y por tanto la distancia real sería mayor— es incorrecta, porque atiende al sesgo pequeño y omite el grande. Y la reponderación tampoco es un ranking: la ventana sigue sin corregir y el sustituto de «lista de espera» es imperfecto por exceso. Lo que entrega es un intervalo defendible, no un puesto en una tabla. Conviene además subrayar lo que el ejercicio deja en pie, porque es mejor hallazgo que el que reemplaza: para las razones que Europa mide, Colombia está en el rango europeo; lo que Colombia tiene y Europa dejó de medir en 2015 es la barrera administrativa, y es exactamente ahí donde esta serie encuentra el deterioro.

3.5 Urgencias: aquí no hay nada

La OCDE no publica ningún indicador comparado de tiempos de espera en servicios de urgencias. Su dominio de tiempos de espera cubre siete procedimientos quirúrgicos electivos —catarata, cadera, rodilla, histerectomía, prostatectomía, *bypass* y angioplastia— en veinticuatro países, Colombia incluida. La propia OCDE reconoce en su informe de 2020 que varios países miden urgencias, y en la misma página advierte que «la definición y medición de los tiempos de espera varía significativamente entre países, lo que limita la comparabilidad de los datos». No hay serie publicada.

Los únicos referentes son nacionales y administrativos. Inglaterra tiene una meta de atender al 95 % de los pacientes de urgencias en cuatro horas, y en diciembre de 2025 cumplía el 73,8 %. Australia reporta una mediana de dieciocho minutos y un percentil 90 de una hora cincuenta y ocho. Ninguno es comparable con un autorreporte de hogares, y el umbral colombiano de una hora no tiene contraparte normativa internacional: es una convención del instrumento.

3.6 El cuadro completo

Indicador ENCV 2025	Referente internacional disponible	¿Comparable?	Por qué
Medicamentos no entregados 46,9 %	Ninguno estandarizado en hogares. Lo más cercano: Brasil, PNS 2019, 81,8 % de acceso total a lo recetado (≈18,2 % incompleto).	Parcialmente, y solo con Brasil	El ODS 3.b.3 mide establecimientos, no personas. El Commonwealth Fund mide renuncia por costo, no falla de entrega. Brasil usa ventana de dos semanas y denominador de usuarios del SUS.
Necesidad de atención no satisfecha 35,9 %	EU-SILC, serie hlth_silc_08b: UE-27 3,6 % en 2024 y 2025; Grecia 21,9 % (2024); Chipre 0,1 %.	No	Ventana de 30 días frente a 12 meses; la europea restringe las razones a costo, lista de espera y distancia, y se limita a mayores de 16 años.
Espera de más de una hora en urgencias 36,0 %	No existe. La OCDE publica tiempos de espera de siete procedimientos quirúrgicos electivos, no de urgencias.	No	Los referentes disponibles son nacionales y administrativos: la meta inglesa de cuatro horas y el percentil 90 australiano de 1 h 58 min. Relojes y unidades distintas.
Afiliación al SGSSS 97,2 %	OCDE, cobertura poblacional: Colombia 98,9 % (2023); 21 países en 100 %. ODS 3.8.1: Colombia 82, mundo 71.	Sí, con dos advertencias	La cifra OCDE es de registro administrativo y la de la ENCV es autorreporte. Y el ODS 3.8.1 no mide afiliación sino cobertura efectiva de servicios.

Cuadro 1. Referentes internacionales disponibles para cada indicador y su límite de comparabilidad. Fuentes: metadato del ODS 3.b.3 (Naciones Unidas); Observatorio Mundial de la Salud (ODS 3.8.1); Eurostat, serie hlth_silc_08b; OCDE, *Health at a Glance* 2025; Commonwealth Fund, encuesta internacional de política de salud 2024; IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

4. La vara que Colombia tiene el mandato de fijar

4.1 El artículo 7

Si el marco internacional deja el umbral en manos del Estado, la pregunta se traslada: ¿lo fijó Colombia? La respuesta empieza por una norma que existe y es exigible. El artículo 7 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 dice, textualmente:

«El Ministerio de Salud y Protección Social divulgará evaluaciones anuales sobre los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en función de los elementos esenciales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Con base en los resultados de dicha evaluación se deberán diseñar e implementar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población. El informe sobre la evolución de los indicadores de goce efectivo del derecho fundamental a la salud deberá ser presentado a todos los agentes del sistema.»

Periodicidad anual, sujeto obligado explícito, contenido anclado en los cuatro elementos esenciales, y una obligación derivada: usar los resultados para diseñar política. Lo que la norma no fija —y de ahí se siguen todos los problemas— es la metodología, el número de indicadores, ni los umbrales de cumplimiento.

4.2 Qué se publicó, y qué no

Los informes existen para **2021, 2022, 2023 y 2024**, elaborados por la Oficina de Calidad del Ministerio, y el de 2024 cita el artículo 7 como fundamento. Para los años 2015 a 2020 no fue posible localizar públicamente ningún informe, y el de 2025 tampoco estaba disponible al momento de esta consulta. Conviene declarar el límite de esa afirmación: la ausencia en un repositorio no prueba de forma absoluta la inexistencia del documento; lo verificado es que no es públicamente localizable.

Hay además un hecho que cambia la naturaleza del problema: **ninguna resolución adopta la batería de indicadores**. Las tablas de los informes de 2023 y 2024 declaran como fuente «elaboración propia». La Resolución 256 de 2016, que suele citarse en este contexto, regula el sistema de información para la calidad y ni siquiera menciona la Ley 1751. La batería es un producto metodológico interno, variable de un año a otro y sin respaldo normativo.

4.3 Lo que dijo la Corte

El 3 de septiembre de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 valoró ese componente con nivel de cumplimiento **bajo**. Su texto es directo: persiste «la ausencia de información clara sobre la implementación efectiva de los 30 indicadores definidos por la autoridad obligada»; en 2022 se usaron 20; en el informe de 2023 «no se identificaron con precisión los indicadores utilizados»; en 2024 se aplicaron 24, «sin consolidar una metodología uniforme entre vigencias». Y concluye que la falta de uniformidad, claridad y continuidad «constituye un **retroceso sustantivo**» respecto de lo ordenado en 2008.

Tres conteos distintos de indicadores en tres años, sin norma que los adopte y sin comparabilidad interanual, declarado así por vía judicial. Diecisiete años después de la T-760.

4.4 Y ninguno tiene meta

El informe de 2024 organiza sus 24 indicadores en los cuatro elementos esenciales. Bajo accesibilidad incluye tres de medicamentos: usuarios que reciben órdenes, usuarios que requieren autorización y la obtienen, y usuarios que reciben los medicamentos. Reporta sus niveles.

No declara para ninguno una meta, un umbral ni un estándar de cumplimiento. Las únicas comparaciones internacionales del informe son para camas hospitalarias —contra los rangos de la OMS y el promedio de la OCDE— y para densidad de talento humano, contra la meta de la OMS de 44,5 profesionales por diez mil habitantes al 2030. Para acceso a medicamentos no hay referente de ningún tipo.

Es decir: el instrumento que la ley creó para evaluar el goce efectivo del derecho **reporta niveles sin vara**, exactamente el mismo problema que este documento vino a examinar, pero en el lugar donde la ley ordenó resolverlo.

5. Dos cifras oficiales del mismo fenómeno

Queda un punto que no se puede eludir. El indicador oficial de goce efectivo mide lo mismo que el documento DT-01 de esta serie, y da un número distinto.

	Indicador oficial de goce efectivo	Este trabajo
Cifra 2024 / 2025	27,93 % no recibió todos los medicamentos en la entrega inicial (2024)	46,9 % no recibió todo lo formulado (2025)
Instrumento	Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE)
Tamaño	15.377 encuestados	235.350 personas; 3.621 en el denominador del indicador
Marco muestral	Usuarios de servicios de salud	Hogares, muestra probabilística con representatividad departamental
Denominador	Quienes recibieron órdenes de medicamentos (75,17 % de los encuestados)	Quienes recibieron fórmula médica
Momento medido	La <i>entrega inicial</i> : la primera solicitud	Si recibió o no todo lo formulado
Error estándar publicado	No	Sí, por linealización de Taylor sobre el diseño muestral
Serie comparable	No. El informe de 2023 reporta 86,06 % y el de 2024, 72,03 %, con metodología distinta	Trece rondas, 2012–2025, con las rupturas declaradas

Cuadro 2. Ficha comparada de las dos mediciones. Fuentes: Ministerio de Salud y Protección Social, *Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024*; cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

Diecinueve puntos de distancia entre dos cifras oficiales del mismo país sobre el mismo año aproximado y el mismo fenómeno. La explicación no requiere suponer que alguna esté mal: las dos miden cosas distintas, y las tres diferencias del cuadro lo explican.

El marco muestral. Una encuesta de usuarios de servicios de salud interroga a quien llegó al servicio. Una encuesta de hogares alcanza también a quien no llegó. Es el mismo sesgo de selección que el documento DT-05 desarrolla para urgencias, operando aquí sobre el acceso al medicamento.

El momento medido. El indicador oficial pregunta por la *entrega inicial* —la primera solicitud—. El de la ENCV pregunta si recibió o no todo lo formulado. Son preguntas distintas y la segunda es más exigente.

El tamaño y el diseño. 15.377 encuestados frente a 235.350 personas en muestra probabilística con representatividad departamental y errores estándar publicados. Eso no convierte automáticamente a una en correcta y a la otra en equivocada, pero sí determina qué puede afirmarse con cada una: solo una de las dos permite decir cuánta incertidumbre tiene su propia cifra.

Conviene además una advertencia sobre la serie oficial. El informe de 2023 reporta que el 86,06 % recibió los medicamentos a la primera solicitud, y el de 2024, el 72,03 %. **Esas dos cifras no son comparables entre sí** —cambió la metodología—, y cualquier titular sobre una caída de catorce puntos sería un artefacto. Es la misma clase de error que el documento DT-04 documenta para la prevalencia de enfermedad crónica.

Lo que este documento sostiene no es que una cifra desplace a la otra. Es que **la coexistencia de dos mediciones oficiales no conciliadas, sobre un derecho fundamental, sin que ninguna declare una meta, es en sí misma el problema**. No es una discrepancia estadística: es un vacío de gobernanza del dato.

6. Qué se puede afirmar, y qué no

No se puede afirmar que el 46,9 % de entrega incompleta constituya una violación del derecho a la salud, porque no existe umbral que lo defina. Tampoco que sea aceptable, por la misma razón. No se puede rankear a Colombia frente a Europa en necesidad de atención no satisfecha, ni frente a la OCDE en espera de urgencias.

Sí se puede afirmar, y con respaldo:

- Que el nivel de 2025 está +12,2 puntos porcentuales por encima del propio nivel prepandémico de Colombia, con una diferencia que se distingue de cero. *La comparación consigo mismo no necesita referente externo*, y es la más sólida de todas.
- Que la distancia frente al único comparador internacional razonable —Brasil, entre 18 % y 30 % según el denominador que se use, con ventana más corta— es grande.
- Que Colombia tiene 82 sobre 100 en cobertura efectiva de servicios y 97,2 % de afiliación, y que la brecha entre ambas cifras es lo que estos indicadores miden.
- Que el indicador de acceso, reponderado al conjunto de razones que EU-SILC admite, queda en 3,51 % (IC 95 %: 2,63–4,39) frente al 3,6 % de la UE-27, y hasta 7,76 % con la cota superior más generosa: la brecha que sugiere la comparación cruda es sobre todo un artefacto del instrumento.
- Que el Estado colombiano tiene desde 2015 la obligación legal de fijar sus propias referencias y no lo ha hecho, y que la Corte Constitucional lo declaró en septiembre de 2025.

7. Cómo se fijaría la vara

La guía del ACNUDH ofrece el procedimiento, y tiene la virtud de no requerir que nadie invente un número de la nada. Una referencia puede construirse de dos maneras.

Por vía normativa, adoptando un estándar externo con fundamento propio. Para medicamentos existe uno disponible y con aval de la Asamblea Mundial de la Salud: el 80 % de la meta 9 del Plan de Acción Mundial sobre enfermedades no transmisibles. Está definido sobre disponibilidad en establecimientos, de modo que trasladarlo a entrega efectiva exigiría un ejercicio de equivalencia explícito y discutible — pero es un punto de partida documentado, que es más de lo que hay hoy.

Por vía empírica, fijando una trayectoria en vez de un nivel. El propio ejemplo del ACNUDH lo plantea así: mejorar la cobertura existente en un número determinado de puntos porcentuales, con fundamento en la disponibilidad de recursos y la capacidad local. Aplicado aquí: volver al nivel prepandémico de 34,7 % es una meta verificable, con línea de base publicada y con plazo. No requiere resolver la pregunta filosófica de cuánto es aceptable.

Cualquiera de las dos vías es preferible a la situación actual, y la diferencia entre ellas es menos importante que el hecho de escoger una. Lo que hoy existe es un instrumento que reporta niveles y no compromete a nada.

8. Límites de este documento

La búsqueda de referentes no es exhaustiva. Documenté la ausencia de un estándar internacional para entrega de medicamentos en hogares y para espera en urgencias consultando las fuentes donde estarían si existieran — metadatos de los ODS, bases de la OCDE, la encuesta del Commonwealth Fund, encuestas de hogares de cuatro países latinoamericanos—. Una ausencia verificada así es evidencia razonable, no prueba definitiva.

Algunas fuentes no fueron accesibles directamente. El texto de los autos de seguimiento de la T-760 se verificó sobre reproducciones íntegras del documento oficial, con membrete y parte resolutive completa, pero no fue posible cotejarlas contra el portal de la Corte Constitucional. La formulación textual de la meta 9 del plan de la OMS se confirmó a través de literatura revisada por pares que la cita, no sobre el documento original. Ambas cosas se declaran aquí para que quien cite pueda cerrar la verificación.

La comparación con el indicador oficial es de fichas técnicas, no de resultados. Sin acceso al microdato de la Encuesta Nacional de Satisfacción no es posible reconstruir su estimación ni calcular su incertidumbre, de modo que la brecha de diecinueve puntos se describe y se explica, pero no se descompone.

9. Implicaciones

Primero: adoptar la batería por acto administrativo. Mientras los indicadores de goce efectivo sean «elaboración propia» variable año a año, no hay serie, no hay seguimiento y no hay rendición de cuentas posible. Es la orden que la Corte viene reiterando desde 2016 y que sigue sin cumplirse.

Segundo: fijar al menos una meta por elemento esencial. No hacen falta veinticuatro umbrales. Hacen falta cuatro referencias defendibles, una por cada elemento del artículo 6, con su fundamento declarado —normativo o empírico— y su plazo.

Tercero: conciliar las dos mediciones de medicamentos. Un ejercicio de concordancia entre la Encuesta Nacional de Satisfacción y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, publicado, explicaría la brecha y le daría al país una sola cifra defendible. Hoy tiene dos y ninguna con meta.

Cuarto: usar la comparación que sí es válida. La más sólida de todas las comparaciones disponibles no es internacional: es la de Colombia consigo misma, contra su propio nivel prepandémico, con el error estándar a la vista. No requiere permiso de nadie ni resuelve ninguna discusión metodológica pendiente, y basta para sostener que tres indicadores del sistema están hoy en su peor nivel del diseño muestral vigente.

Quinto: no confundir la ausencia de vara con la ausencia de problema. Es la tentación que este documento quiere cerrar. Que no exista un umbral internacional que declare inaceptable el 46,9 %

no significa que sea aceptable. Significa que la decisión de declararlo aceptable o no *le corresponde al Estado colombiano*, que la ley se la asignó hace diez años y que no la ha tomado.

BORRADOR

·. Referencias

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). *Observación General 14: el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud* (E/C.12/2000/4), párrs. 12, 43, 47, 57 y 58. Naciones Unidas.
- Commonwealth Fund. (2024). *2024 International Health Policy Survey of Older Adults*. Nueva York.
- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículos 6 y 7. Diario Oficial 49.427.
- Corte Constitucional de Colombia, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. (2025, 3 de septiembre). *Auto 1280 de 2025*, fundamentos jurídicos 87–89. M. S. José Fernando Reyes Cuartas.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Eurostat. (2026). *Self-reported unmet needs for medical examination due to financial reasons, long waiting list or distance, by sex, age and risk of poverty threshold — % of the persons having the same needs* (serie hlth_silc_08b). Luxemburgo.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2020). *Pesquisa Nacional de Saúde 2019: acesso e utilização dos serviços de saúde*. Río de Janeiro: IBGE.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, abril). *Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 — Orden Trigésima*. Bogotá: Oficina de Calidad.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). *Informe de Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2023 — Orden Trigésima*. Bogotá: Oficina de Calidad.
- Naciones Unidas, División de Estadística. (2019). *SDG indicator metadata 3.b.3: proportion of health facilities that have a core set of relevant essential medicines available and affordable on a sustainable basis*. Nueva York.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2012). *Human rights indicators: A guide to measurement and implementation* (HR/PUB/12/5). Ginebra.
- Oldfield, L., Penm, J., Mirzaei, A., y Moles, R. (2025). Prices, availability, and affordability of adult medicines in 54 low-income and middle-income countries: evidence based on a secondary analysis. *The Lancet Global Health*, 13(1), e50–e58.
- Organización Mundial de la Salud. (2013). *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020*, meta voluntaria mundial 9. Ginebra: OMS.
- Organización Mundial de la Salud. (2025). *Global Health Observatory: UHC service coverage index (SDG 3.8.1)*. Ginebra.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020). *Waiting times for health services: Next in line*. París: OCDE.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *Health at a Glance 2025*. París: OCDE.
- Sentencia T-760 de 2008. Corte Constitucional de Colombia. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Descargo. Las opiniones, análisis y propuestas de este documento son exclusivamente del autor, a título personal. No comprometen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al Ministerio de Salud y Protección Social, ni a ninguna otra entidad del sector. El trabajo se elabora íntegramente a partir de fuentes de acceso público: microdatos anonimizados del DANE, normatividad publicada, informes oficiales y bases de datos internacionales abiertas. No emplea información reservada, datos personales de beneficiarios ni información de operación contractual. Las propuestas son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Serie «Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo». El código de procesamiento, el catálogo de campos y las verificaciones contra los boletines oficiales son reproducibles. Cualquier error es responsabilidad del autor.